

14 - 02- L'écoulement urétral - Pr. Amal

Bonjour, donc, après avoir vu le cours sur les ulcérations génitales, nous allons voir maintenant et toujours dans le cadre des infections sexuellement transmissibles, le cours intitulé les coulements urethrales. Les infections sexuellement transmissibles représentent un problème de santé publique au Maroc. En effet, 300 000 à 600 000 nouveaux cas sont déclarés chaque année, en sachant que ce nombre ne reflète pas la réalité parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne déclarent pas.

Il faut savoir que les infections sexuellement transmissibles sont des maladies à déclaration obligatoire. Les coulements urethrales représentent 19 % de ces IST au Maroc. Les étiologies sont dominées par deux germes qui peuvent être associés, *Neisseria gonorrhoea*, responsable de la gonococcie, et *Chlamydia trachomatis*.

Le diagnostic et le traitement précoce permettent d'éviter les complications, mais il faut faire attention parce qu'il y a des formes frustes qui peuvent passer inaperçues. Près de ce cours, l'étudiant doit être capable de préciser l'épidémiologie des urethrites, de diagnostiquer une urethrite, d'orienter le diagnostic étiologique d'une urethrite, de connaître les complications d'une gonococcie et des urethrites non-gonococciques, de planifier le traitement d'une gonococcie et des urethrites non-gonococciques, et de connaître les principes de la prévention des IST. Sur le plan terminologique, l'urethrite traduit une inflammation de l'urètre, l'écoulement urethral et le cime fonctionnel majeur.

Cet écoulement urethral peut être purulent ou clair, peut être abondant ou minime. Parfois, cet écoulement urethral est absent et le patient peut se plaindre d'autres cimes fonctionnelles tels le pleuriste urethral, une sensation de brûlure soit permanente, ou lors de la mixtion, une désurie. Le diagnostic de cette étude repose sur 10 critères cytologiques.

On parle d'urethrite lorsqu'on a plus de 5 polynucléaires noctrophiles par champ microscopique au niveau de frottis urethrales vues au grossissement 100, ou bien plus de 10 polynucléaires noctrophiles à l'examen du premier jet urinaire au grossissement 400. La sensibilité de ces critères cytologiques est de 60 à 80 % en présence d'un écoulement. Cette sensibilité est réduite lorsqu'il n'y a pas d'écoulement, donc de 30 à 40 %. Cet examen peut être faussement positif en cas d'infection urinaire avec puerie.

À ce moment-là, c'est l'examen cyto bactériologique des urines qui permet de confirmer le diagnostic d'infection urinaire. Devant un patient qui consulte pour un écoulement urethral, l'interrogatoire précise le sexe, l'âge du patient, l'état matrimonial, la profession, chercher s'il y a des antécédents diestés, l'ulcération génitale, la syphilis, l'herpès génital, HIV, préciser l'histoire sexuelle du patient, type de partenaire, homo ou hétérosexuel, le nombre de partenaires, la pratique sexuelle, et le dernier rapport sexuel, l'intervalle entre ce rapport et l'apparition d'écoulement urethral. Lorsque ce rapport, lorsque cet intervalle est de 3 à 5 jours, ça oriente

vers une urethritis gonococcique.

Lorsqu'elle est aux alentours de 10 à 15 jours, ça oriente vers une urethritis non gonococcique. Chez la femme, il faut également préciser les antécédents obstétrico-gynécologiques qui peuvent orienter vers des complications, des infections sexuellement transmissibles. Puis, à la fin, préciser les caractéristiques de l'écoulement.

Un écoulement abondant périllant oriente vers une urethritis gonococcique, un écoulement clair minime oriente plutôt vers une urethritis non gonococcique, chercher s'il y a d'autres signes associés, une brûlure mictionnelle qu'on trouve souvent dans l'urethritis gonococcique, une désurie, un pluriscanal. À l'examen clinique, on précise le caractère de l'écoulement. Par exemple, chez ce patient, chez ce patient-là, on voit cet écoulement qui est périllant, l'enchâtre, ça oriente vers une urethritis gonococcique.

On cherche également s'il y a ou non une myélite sous-jacente. Vous voyez ici une inflammation, donc il y a une myélite associée. Et puis on cherche s'il y a d'autres IST associées, donc on examine s'il y a des ulcérations génitales, s'il y a des lésions vésiculeuses qui orientent vers l'herpès génital, parce que les IST peuvent être associées.

On cherche s'il y a des végétations vénériennes ou s'il y a des adénopathies inguinales. Pour le cadre de l'enquête étiologique, devant un écoulement urethral, on est ramené avec des examens complémentaires. Donc on fait un prélèvement de l'écoulement urethral lorsqu'il y a un écoulement urethral.

Donc, voilà, sur ce patient par exemple, vous voyez, on fait un prélèvement de l'écoulement urethral à l'aide d'un nicouvillon. Et puis on fait l'examen à l'état frais de cet écoulement entre l'âme et la main dans une goutte de sérum physiologique. L'intérêt de cet examen, c'est de voir s'il existe une parasite, donc qui s'appelle TRIC, menace vaginaliste, qui est responsable d'une uréthrite non gonococcique et qui peut être associée parfois à l'uréthrite gonococcique.

On fait également un examen de cet écoulement sur l'âme colorée par le bleu de mythylène ou le grain pour le diagnostic de l'uréthrite gonococcique. La même chose pour l'uréthrite gonococcique, on fait une mise en culture sur gelose chocolat. En absence d'écoulement urethral, on peut faire un prélèvement ondo-urethral et à ce moment-là, il y a un nicouvillon spécial pour ça, parce qu'il faut introduire l'écouvillon, il est métallique et il est dur à l'intérieur de l'urètre et il faut racler.

C'est douloureux. Et on peut, bien sûr, un examen du premier jet d'urine, en général deux heures après la dernière miction. On fait un prélèvement du premier jet d'urine.

Ça permet de confirmer le diagnostic d'uréthrite, parce qu'on a dit que le diagnostic d'uréthrite est cytologique. À ce moment-là, on a plus de 10 polynucléaires neutrophiles au grossissement 400 et ça permet de mettre en évidence le chlamydia par PCR. Maintenant, on va voir les différentes

étiologies des uréthrites.

Donc, on a dit qu'il y a deux germes essentiels. Donc, on va commencer par l'urétrite gonococcique, donc le germe pathogène est *Neisseria gonorrhoeae*. C'est un bacille gramme négatif.

Donc, c'est un diplococ surtout intracellulaire ou parfois extracellulaire. Donc, l'incubation, elle est courte de deux à cinq jours. L'incubation, c'est-à-dire, c'est l'intervalle entre le rapport sexuel, source de contamination et l'apparition de l'écoulement uréthral.

Donc, sur le plan clinique, l'urétrite gonococcique chez l'homme se présente le plus souvent sous forme d'urétrite aiguë, donc 80, plus de 80% des cas. Donc, ça veut dire que le tableau clinique est brouillon, c'est ça l'urétrite aiguë. Ça veut dire qu'on est devant un poumon abondant, urulent.

Vous voyez ces deux patients associés à une myatite peut y avoir des douleurs urétrales à type de brûlure permanente ou mixionnelle, impureté urétrale. Donc, ça c'est un tableau brouillon. Parfois, dans moins de 10% des cas, on est devant un tableau d'urétrite subaiguë.

Lorsqu'on parle d'urétrite subaiguë, ça veut dire que les signes sont moins brouillants que par rapport à la forme aiguë, c'est-à-dire que les coulmons éliminés, les coulmons parfois éclairs, peut-être absents. On peut trouver impureté, une sensation de brûlure intracanalé ou impureté urétrale. Le portage asymptomatique est possible, mais exceptionnel.

Chez la femme, l'infection gonococcique, l'urétrite gonococcique est asymptomatique dans 50 à 90% des cas. Le tableau le plus fréquent est la cervicite, c'est-à-dire une inflammation au niveau du col de l'utérus. Donc, on peut trouver un col inflammatoire et parfois un écoulement à l'orifice urétral.

Il peut y avoir également des localisations pérurétrales ou un écoulement urétral. Il peut y avoir des localisations extra-génitales en fonction de la nature du rapport sexuel. Les deux localisations les plus fréquentes, c'est la localisation paringée et anorectale.

L'anorectite peut survenir dans les deux sexes, mais elle prédomine chez l'homme. Elle est asymptomatique dans la majorité des cas. Donc, à peu près les deux tiers des cas sont asymptomatiques.

Et il peut se manifester par un prurite anal, une anite, un écoulement rectal pérurant, une diarrhée, des saignements anorectaux, un syndrome rectal, c'est-à-dire des ténésmes, des épreintes, des diarrhées micopérurantes et ou des sensations de défécation incomplète. Par contre, l'oropharyngite est le plus souvent asymptomatique. Donc, il faut chercher des tests systématiquement et il faut faire un examen de la muqueuse buccale, l'oropharynge.

Le diagnostic de certitude de l'urétrite gonococcique est un diagnostic bactériologique. Les prélèvements doivent être réalisés au niveau de l'écoulement urétral, s'il y a un écoulement

urétral, bien sûr. Sinon, on fait un prélèvement ondo-urétral, comme on vient de voir tout à l'heure.

On fait un examen de premier jet urinaire, surtout à la recherche du clamidier, qui peut être associé à l'irritrice gonococcique. Chez la femme, les prélèvements doivent être faits au niveau de l'onde de colle, puisqu'on a dit que la cervicite est la forme clinique la plus fréquente, au niveau de l'urètre, au niveau du vagin, au niveau du gland de Barthelin. L'examen direct est sensible et spécifique chez l'homme.

Il permet de mettre en évidence des diplococs grains négatifs, sous forme de grains de café, à l'intérieur des cellules. Cet examen, il n'est pas sensible et il n'est pas spécifique chez la femme, parce qu'il y a des germes à profit, et également chez l'homme dans des localisations extra-génitales, anorectales ou oropharyngées. Donc, la culture se fait sur, donc, milieu gel au chocolat ou milieu de taille à martin sans cuit.

Ça permet de confirmer le diagnostic, les résultats sont rapides, 24 à 48 heures, et également permet de donner l'antibiogramme au clinicien. Non traité, l'irritrice gonococcique peut se compliquer. Il peut y avoir des complications locorégionales et des complications générales chez l'homme.

Donc, il y a la diffusion de l'infection avec un risque d'atteinte du prostate, donc une prostatite, qui se traduit par une fièvre élevée aux alentours de 39 degrés, des douleurs, une désurie. Il peut y avoir l'extension de l'infection vers le canal épидидymaire, donnant une épидидymite ou une orchie épидидymite avec une inflammation au niveau de la bourse et des douleurs testiculaires, une vésiculite qui se traduit le plus souvent par l'existence du son au niveau du sperme, et donc, ainsi de suite, il peut y avoir une infection au niveau de la semiveuse urétrane avec des risques d'absédation. Chez la femme, la même chose, il peut y avoir des complications locorégionales avec l'extension de l'infection à l'endomètre, donnant une endométrite qui se traduit donc par une fièvre, par des douleurs péloviennes, par un saignement anormal, par des pertes vaginales.

Il y a deux formes d'endométrites, la forme aiguë, la forme chronique. Dans la forme chronique, donc, en général, les symptômes sont moins brouillants. La salpingie, donc, avec le risque par la suite de grossesse extra-utérine, il peut y avoir l'extension de l'infection au niveau des glandes de Sken et des glandes de Bartonnat, donnant des abcès, donc avec des douleurs très importantes, une inflammation importante.

La maladie inflammatoire péloviennne, en général, c'est une maladie qu'on voit chez les femmes, donc, qui ont fait beaucoup d'infections sexuellement transmissibles et qui se plaignent d'une douleur péloviennne chronique. Il y a des complications obstétricales et le risque de grossesse extra-utérine. Pour les complications générales, il y a la conjonctivite néonatale, donc à l'infection du nouveau-né par passage de la filière génitale, et c'est pour cela qu'on prend systématiquement des antibiotiques boutofthalmiques pour les nouveaux-nés.

Il y a la conjonctivite périllante de l'adulte, donc c'est une conjonctivite maniportée et il y a le risque de septicémie sub-aiguë. Donc, la septicémie ici, ce n'est pas la septicémie classique avec les troubles hémodynamiques. Donc, on trouve en général une fièvre qui n'est pas très élevée.

On peut trouver également une atteinte cutanée à type de purpura pitégliale. On peut trouver des papules ou des papulopistules localisées au niveau des extrémités ou au regard des articulations. Il y a aussi, on peut trouver une atteinte articulaire type mono ou au niveau arthrite septique ou des ténocénobites.

Parfois, on peut trouver une endocardite ou une méningite. Donc, le diagnostic clinique à ce stade, il est difficile parce qu'il y a, donc on ne trouve pas les signes urogéniques. Voici une conjonctivite chez l'adulte.

Un rouge avec les sécrétions périllantes. Donc, c'est une conjonctivite maniportée. Voici des lésions de pistules au niveau des extrémités.

Donc là, c'est un tableau de septicémie sub-aiguë. Il faut penser à ça devant ces lésions pistuleuses ou papulopistuleuses localisées au niveau des extrémités ou au regard des articulations. Donc, parfois associé à une monoarthrite septique.

Le traitement de l'urtrite gonococcique doit répondre aux principes de traitement des infections sexuellement transmissibles, à savoir le choix d'un traitement minute pour stopper la chaîne de contamination et pour assurer l'observance du traitement. Il faut traiter le ou les partenaires et il faut bien sûr dépister les autres maladies sexuellement transmissibles. Donc, il faut faire de la sérologie de la syphilis, le VIH après consentement du patient, donc l'hépatite B et C. L'histoire thérapeutique du gonococci ou de l'urtrite gonococcique a été marquée par l'émergence successive des résistances.

Au départ, résistance à la PNG, qui était le traitement classique, puis les cyclines et plus récemment les fluoroquinolones et actuellement on a même décrit quelques cas de résistance au sépharosporine de troisième génération. Donc, le traitement actuel de première intention, c'est le sépharosporine de troisième génération, donc on donne la Cef-Triaxone 500 mg, dose unique en injection intramusculaire, ou sépharosporine de troisième génération PEROS, donc Cefixime 400 mg par voie orale. En deuxième intention, on peut donner la Spixinomycine 2 g en intramusculaire.

La Spixinomycine fait partie de la famille des aminoïdes, donc elle est contre-indiquée chez les patients qui ont une insuffisance rénale. Et en dernier lieu, on peut donner la Ciprofloxacine 500 mg plus unique. Il y a des boîtes commercialisées, on trouve deux comprimés, un pour le patient et un pour le partenaire, mais on a dit qu'il y a actuellement émergence des résistances aux fluoroquinolones.

Il faut associer systématiquement au traitement du clavidia parce que l'association, elle est

fréquente, aux alentours de 15 %, et le clavidia, il est très difficile de le mettre en évidence, donc on donne un traitement qui vise ces deux germes, donc le gonocoque et le clavidia. L'urétrite à clavidia représente la deuxième étiologie après l'urétrite gonococcique. Donc elle représente 20-50 % de l'urétrite non-gonococcique, mais dans les pays industrialisés, elle représente la première étiologie de l'urétrite.

Elle se voit surtout chez les femmes jeunes en période d'activité génitale et qui ont des partenaires multiples. C'est la première cause de stérilité tubaire, donc elle représente à peu près 70 % de stérilité tubaire et 50 % de salpingite. Le clavidiae trachomatis est une bactérie intracellulaire obligatoire et ce sont les sérotypes de DAK qui sont responsables de l'urétrite à clavidiae.

Nous avons déjà vu les sérotypes L1, L2, L3. Elles donnent la lymphogranulomatose vénéreuse ou la maladie de Nicolas Sfabre. L'incubation en moyenne, elle est de 7 à 15 jours, mais elle peut aller de 3 à 60 jours.

Uniquement, la fréquence du portage asymptomatique, donc 50 % chez l'homme et de 50 à 90 % chez la femme, contribue d'une part au maintien de la chaîne épidémiologique et d'autre part à la cérémonie des complications tardives de l'infection. Chez l'homme, donc le tableau le plus fréquent, c'est l'urétrite sub-aiguë avec un écoulement qui est donc clair, minime, modéré et intermittent. Il n'y a pas de méatite.

Ce n'est pas comme dans l'urétrite gonococcique où on a un écoulement pérurant, blanchâtre, abondant. Parfois, il y a une balamite. Chez la femme, la forme clinique la plus fréquente, c'est la cervicite.

Vous voyez ici. Donc, la cervicite, elle est le plus souvent asymptomatique, mais peut être évaluée par des locorées blanchâtres ou jaunâtres, parfois des cystalgies, un syndrome urétéral ou une disparunie. Donc, l'examen physique peut montrer une fragilité du col utérin de sécrétion mycopéurante.

Pour le diagnostic biologique, tout d'abord, les prélèvements bactériologiques peuvent être pratiqués chez l'homme symptomatique ou non sur l'examen du premier jet urinaire, 10 à 20 millilitres, au moins deux heures après la dernière miction. Chez la femme symptomatique, sur un écouvillonnage d'endocolles et périurétrales lors d'un examen au spéculum en réalisant un raclage de la muqueuse. Chez la femme asymptomatique, on utilise donc un écouvillonnage vulvo-vaginal.

Donc, en pratique, c'est la PCR qui est devenu l'examen clé du diagnostic des chlamydioses. La PCR, l'amplification génique par PCR, elle est plus sensible que la culture. La culture sur milieu cellulaire a une spécificité proche de 100% et une sensibilité de 50 à 80%.

Elle est réservée aux laboratoires de recherche et n'est pas recommandée en routine. La

détection des antigènes de chlamydia trachomatis n'est plus pratiquée ou n'est plus recommandée. Certains laboratoires continuent à utiliser ces examens rapides directs, mais en général, ils sont peu sensibles.

Les chirurgies, la même chose. Il n'a pas d'intérêt dans le diagnostic des infections à chlamydia. Il ne permet pas de distinguer une infection active d'une infection ancienne.

Le retrait à chlamydia non traité peut se compliquer. Il peut y avoir des complications locorégionales et des complications générales. Donc, chez l'homme, il peut y avoir un tableau de prostatite, comme on vient de voir tout à l'heure pour l'urétrite gonococcique.

C'est le même tableau clinique avec une fièvre, une douleur pré-pelvienne, des urines. Et également, il peut y avoir une épidémie ou une orchépidémie, donc une inflammation importante avec des douleurs testiculaires. Et secondairement, il peut y avoir un retrait urétrale.

Chez la femme, la même chose, donc un tableau d'endométrite avec des pertes vaginales ou insaignements, des douleurs pélviennes, une fièvre. La même chose pour la salpingite. C'est peut-être un tableau aigu ou suraigu, donc fièvre, douleurs pélviennes.

Et la pelvipéritonite, qui se traduit par des algies pélviennes inflammatoires. La périhépatite, donc, donnant des douleurs au pocondre droit ressemblant au cholecystite. Et le rétrite chlamydien également, elle est responsable de 70% des stérilités tubaires et elle peut occasionner des grossesses extra-utérines.

Pour les complications générales, chez le nouveau-né en cas d'infection génitale maternelle, il peut y avoir une keratoconjonctivite, une pneumopathie. Chez l'adulte, donc dans les deux sexes, il peut y avoir le syndrome de Fessinger-Leroy-Reiter qui associe des polyarthrites aigus ou subaigus réactionnels, un tableau d'uritrates, une conjonctivite bilatérale, une balanite cercinée, une keratodermie palmoplantaire psoriasiforme, des keratoconjonctivites et des arthritides. Donc on voit ici donc des conjonctivites, vous voyez les oeufs rouges.

Il n'y a pas de sécrétion pérulente comme dans les rétrites bronopoxiques. Vous voyez la teinte articulaire, donc il peut y avoir une arthrite ou des polyarthrites. La teinte, donc une balanite cercinée.

Donc ça c'est le syndrome de Fessinger-Leroy-Reiter qui associe une keratoconjonctivite, une uritrite, une arthrite, une balanite et il peut y avoir une keratodermie palmoplantaire psoriasiforme, c'est-à-dire qu'un épaissement, donc la couche cornée au niveau de la paume des mains et parfois donc les plantes du pied qui ressemblent à ce qu'on voit, à la keratodermie qu'on voit dans le cadre du psoriasis. Pour le traitement du chlamydia, donc le chlamydia est une bactérie intracellulaire, donc il faut des antibiotiques qui ont une bonne diffusion intracellulaire. On utilise donc les cyclines et les macrolides.

Donc les cyclines 500 mg fois 4 par jour, donc c'est 2 grammes par jour ou la doxycycline 200 mg par jour. Pour les formes non compliquées, la durée de traitement est de 7 jours. Pour les formes compliquées, il faut 15 jours de traitement.

On peut utiliser l'azithromycine, donc c'est un macrolide, une prise unique, un grain par voie orale. On a dit qu'en matière de maladies sexuellement transmissibles, il vaut mieux choisir le traitement en minutes pour stopper la chaîne épidémiologique et pour améliorer l'observance du traitement. Il faut voir le patient, le contrôler 7 jours après le traitement, et bien sûr, il ne faut pas oublier de demander et de chercher des maladies sexuellement transmissibles.

Donc on demande une sérologie séquellétique, VDRL quantitatif, DPHA qualitatif. On fait une sérologie achevée après consentement du patient 3ème mois, 6ème mois. L'antigène HBS, l'anticorps antihépatite virale C. Après avoir vu les deux grandes étiologies, l'urétrite gonococcique et l'urétrite aclamydia trachomatis, on va voir donc brièvement les autres étiologies des uréthrites.

Donc on a l'urétrite atrichomonas vaginalis. L'urétrite atrichomonas vaginalis est un parasite protozoaire flagellé. Elle est responsable de 5 à 15 % des uréthrites non gonococciques chez l'homme.

Chez la femme, elle donne un tableau de vulvovaginite. Cette urétrite, elle peut être associée également à l'urétrite gonococcique dans 15 à 60 % des cas. Cliniquement, on a un tableau d'urétrite aiguë dans 5 % des cas, mais le plus souvent, c'est un tableau d'urétrite subaiguë qui ressemble à l'urétrite aclamydia trachomatis avec un écoulement clair, peu abondant et sans signe bruyant.

Donc, elle peut donner un tableau également de balanite de prostatite et dans 30 % des cas, il y a des portages asymptomatiques chez l'homme. Chez la femme, le tableau, c'est dans 90 % des cas, c'est un tableau de vulvovaginite avec des leucorrhées. Il y a des femmes porteuses asymptomatiques dans 50 % des cas.

Chez la femme, des pertes vaginales, des leucorrhées blanchâtres, malodorantes. Le diagnostic biologique repose sur la mise en évidence du parasite, soit après l'examen direct des sécrétions à l'état frais entre l'âme et la mèche, soit après coloration homé-grenouille Il y a des milieux de culture spécifique, milieu de roi rond ou plus vert, mais ce n'est pas d'utilisation courante. Le traitement, c'est à base de nitro-imidazole par voie orale et chez la femme, on associe à ce traitement des ovules gynécologiques pendant des jours, des ovules de nitro-imidazole.

Les mycoplasmes sont des bactéries dépourvues de parois difficiles à cultiver. En partie de la flore vaginale et également la flore urétrale. Ce sont des micro-organismes saprophytes, d'où leur incrimination dans les uréthrites reste difficile à prouver.

Cependant, les deux germes les plus fréquemment impliqués dans les uréthrites chez l'homme, on

note surtout l'uréoplasma *uriolaticum*, responsable de 10 % des urétrites non-gonococciques. Mycoplasme génital homme, chez la femme, c'est Mycoplasme *ominus*. En cliniquement, l'urétrite en mycoplasme se présente sous forme de tableau d'urétrite sub-aiguë chez l'homme, avec un écoulement clair peu abondant.

Il peut y avoir des complications locorégionales, type de prostatite, visiculite. Chez la femme, le plus souvent, le tableau est asymptomatique ou un tableau clinique frustré avec des locorées peu abondantes. Il peut se compliquer d'endométrite, de salpingite aiguë ou sub-aiguë.

Chez les deux sexes, chez l'homme et la femme, il peut y avoir des complications générales à type de syndrome de Fessinger-Leroy-Reiter qu'on vient de voir tout à l'heure avec les complications de l'urétrite *aclamidia*. Il y a également cette complication spécifique de ces urétrites en mycoplasme, les lithiases rénales. La confirmation du diagnostic de l'urétrite en mycoplasme, la PCR, est actuellement l'examen clé pour poser le diagnostic.

Donc cet examen peut être fait sur des prélèvements faits à partir de l'urètre, de l'endocolle et également de l'examen du premier jet urinaire. Le traitement est à base de cyclines et de macrolides. La durée de traitement est de 15 jours.

C'est décrit des cas de résistance aux macrolides. *Candida albicans* peut être également responsable des urétrites sub-aiguës chez l'homme et peut être associée à une balanite. Chez la femme, elle donne un tableau de *ville-beau* vaginite aiguë.

Il faut savoir que *Candida albicans* fait partie de la flore vaginale. Elle peut devenir pathogène en des circonstances particulières, telles la grossesse par exemple, la notion de prise antibiotique, de corticoïdes, d'ostéoprotectifs. Le diagnostic repose sur la mise en évidence de *Candida albicans* dans le milieu de la culture et sur l'examen direct qu'on voit ici qui peut montrer un aspect de pseudo filaments mycéliens.

Le traitement à base de dérivés azotés, donc en antimicrobiens locaux, parfois associé à un traitement général à base de fluconazoles. Donc, il y aura un cours plus détaillé sur les Candidoses. Voici un tableau de *ville-beau* vaginite avec des pertes blanchâtres, des locorées blanchâtres, donc avec un aspect de lait caillé, en général associé à une urétrite importante.

Chez l'homme, ça donne un tableau de balanite avec parsemé parfois de pustules. 62,5 % des urétrites masculines sont dues à des germes *piogènes* tels le streptococcus, staphylococcus aureus ou *Escherichia coli*. Cliniquement, le malade se présente sous forme d'un tableau d'urétrites subaiguës associé à des signes urinaires type dysurie et brûlure mictionnelles.

Pour confirmer le diagnostic d'urétrites masculines à germes *piogènes*, il faut exiger plusieurs prélèvements qui doivent identifier le même germe. Et au niveau du frottis, il faut qu'il y ait des polynucléaires neutrophiles altérés et à la culture, il faut donc un nombre important de colonies. Le traitement est adapté en fonction des données de l'antibiogramme.

Certains patients se plaignent de la persistance des symptômes. C'est des patients qui ont consulté plusieurs médecins. Ils ont reçu plusieurs traitements.

Dans ce cas, il faut chercher s'il y a un foyer microbien inaccessible au traitement, une localisation anorectale, une localisation oropharyngée. Il faut chercher à l'interrogatoire la notion de recontamination. Et il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des associations de germes dans les uréthrites.

Il peut y avoir l'urétrite gonococcique associée à l'urétrite chlamydia classique. Plus souvent, on donne un traitement qui vise ces deux germes, mais il peut y avoir des associations avec trichomonas vaginalis ou avec d'autres germes. D'où l'intérêt de faire des prélèvements pour ces patients et de les analyser.

Enfin, il y a des patients qui souffrent de l'anxiété et qui peuvent provoquer une irritation. Chaque fois, ils cherchent s'il y a un écoulement urétral. Cette irritation peut provoquer la persistance des symptômes.

En guise de conclusion, les deux germes les plus fréquemment responsables des uréthrites sont le gonocoque et le chlamydia. D'où l'intérêt de l'approche syndromique proposée par notre ministère, le ministère de la Santé, et par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de traiter tous patients souffrant d'un écoulement urétral par une antibiothérapie qui vise ces deux germes, qui vise le gonocoque et le chlamydia. Il y a des signes trempés, des formes cliniques asymptomatiques, des formes minimales et frustrées qui peuvent provoquer un retard de diagnostic et de prise en charge et les malades arrivent au stade de complication, la complication majeure et la stérilité chez les jeunes femmes.

Pour la prise en charge des IST, il faut toujours respecter les règles de traitement, prêter les partenaires, dépister cliniquement et biologiquement les autres maladies sexuellement transmissibles, donc faire des sérologies de la syphilis, la sérologie d'HIV après consentement du patient, chercher cliniquement s'il y a des signes qui orientent vers l'herpès, les végétations vénériennes et également demander des sérologies de l'hépatite B et C. Les maladies sexuellement transmissibles sont des maladies liées au comportement humain, d'où le rôle de l'éducation thérapeutique, de l'information et de la sensibilisation.